3.2.1.1. 응급진료센터 진료절차

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	응급진료센터				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 3.2.1 중증응급환자 JCI Standard 7th Edition: ACC.1, 2, 4.2.1, AOP.1.2.1, PCC.1.5, PCI.12, 12.1

제1조 (목적)

1. 응급진료센터의 표준화된 진료 지침을 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 개관
   1) 응급진료센터 질관리 운영위원회의 감독 하에 의사, 간호사, 진료지원부서가 상호협력하여 24시간, 주 7일 응급 진료를 제공한다.
   2) 우선순위에 따라 응급 정도를 분류하며, 우선순위에 의거하여 환자를 진료한다.
   3) 진료 절차와 과정 중에 환자의 안전과 안녕을 구현하고, 환자의 존엄성과 사생활을 존중한다.
   4) 환자의 진료비 부담 능력과 상관없이 적절한 진료를 제공한다.
   5) 입원 시 이용 가능 병상에 의해 배정이 이루어짐으로, 병상운영의 제한이 발생할 수 있다.

2. 진료 절차
   1) 우선순위(Acuity Level)와 접수
      (1) 응급진료센터에 도착한 환자의 중증도 분류는 의사, 간호사 또는 응급 구조사가 시행할 수 있다.
         ① Triage Criteria 지침에 따른 활력징후 측정, 현재 주호소와 관련된 간단한 문진, 과거 병력, 투약, 알러지와 의식상태 등의 환자평가를 통해 환자 중증도를 분류하며 진료우선순위를 결정한다. (1단계: Immediate, 2단계: Emergency, 3단계: Urgent, 4단계: Semi-Urgent, 5단계: Non-Urgent)
      (2) 응급진료센터에 내원한 모든 환자는 중증도분류실에서 Triage 간호사가 분류한다.
      (3) 1, 2 단계 혹은 생명을 위협하는 상태로 분류된 중증응급환자는 A구역 응급의학과 의사에게 즉시 알리고 진료받을 수 있도록 안내한다. 안정된 활력징후를 보이는 3단계 또는 그 이상의 등급으로 분류된 환자는 의사의 진찰을 받을 수 있도록 안내한다.
      (4) 신종 감염병 의심 환자 내원 시 즉각 응급실 출입을 통제하고, 의료진 및 응급실

책임자에게 알리도록 한다. 최초 인지한 직원은 보호장구를 착용하고 격리구역으로 환자를 안내하도록 하며, 정해진 진료 프로세스에 따라 진료를 시행한다.

2) 응급 진료 과정

(1) 의사와 간호사는 내원 초기 환자 상태에 대한 의무기록을 작성한다.

(2) 응급의학과 혹은 소아응급의학과에서 환자 진료를 시작하며, 환자평가와 적절한 치료 후 퇴원 결정을 할 수 있다. 진료 과정 중 협의진료가 필요한 경우, 협의진료를 의뢰하는 의사는 u-Severance에서 응급협의진료의뢰서를 작성하여 전산 협진을 통해 의뢰하며, 협의진료를 의뢰받은 의사는 협의진료의뢰서를 통해 회신한다.

(3) 각 진료과 간의 유기적인 관계를 유지하며, 환자의 의학적 요구에 기반을 둔 주치의(담당교수) 배정을 위해 당직 교수 명단을 응급진료센터에 비치한다.

(4) 효율적인 진료를 위해 접수 후 지켜야 할 시간 제한 규칙

① 응급진료센터 의사는 검사 결과를 확인하고 환자를 재평가하여 퇴원을 결정하며, 필요 시 각 진료과에 협의진료를 의뢰한다.

② 협의진료를 의뢰받은 진료과는 응급실 도착으로부터 3시간 이내에 입원, 퇴원 또는 회송(전원)을 결정한다.

③ 3시간까지 진료과에서 의사결정을 하지 못했을 경우, 응급진료센터 의사나 응급의학과 의사는 치료가 요구되는 시점에서 가장 적합한 임상과 및 의사를 배정하거나 퇴원을 결정하는 권한이 있다.

④ 입원원무팀은 대기절차(holding process)에 따라 입원 결정 후 6시간 이내에 환자가 입원할 수 있도록 우선적으로 입원 침상을 배정한다. 접수된 환자가 위 제한 시간 이후에 응급진료센터에서 입원 침상 배정을 대기할 때에는 지연되는 이유(경제적 문제, 부적합한 병상 종류, 행정 조건 등)와 상관없이 해당 임상과의 다른 모든 외래진료센터를 통한 입원보다 최우선으로 한다.

⑤ 거취결정(ARRANGE CP) CP를 통해 다양한 문제(입원 거취지연, 전원실패, 무연고, 법적/윤리적 이슈 등)로 거취결정이 지연되는 환자의 병원 공식 개입 및 해결지원을 받기 위한 시스템을 가동하여 거취결정이 지연되지 않도록 한다.

(5) 응급환자는 원내약처방전을 적용한다.

(6) 표준진료지침 (CP, Critical Pathway): 근거중심적 표준화된 임상진료를 위해 다학제간 논의를 통해 다음과 같이 질환별 진료지침을 만들어 운영하고 질관리를 수행한다.

① 다음 CP 대상자는 우선순위 2 단계 이상으로 분류하며, 해당 Critical Pathway에 따라 신속한 치료를 시행한다

a. 급성심근경색(FIRST, Fast Interrogation Rule for ST elevation MI)

b. 급성뇌졸중(BEST, Brain salvage through Emergent Stroke Therapy)

c. 패혈성 쇽(SEPSIS, Septic Shock)

d. 분만 후 출혈 환자(SPEED, Severance Protocol to save postpartum blEeding through Expeditious care Delivery)

e. 중증 외상 환자(TRAUMA)

f. 급성천식 발작 환자(AAAAT, Acute Asthma Attack Assessment & Treatment)

g. 저체온 (COOL, Critical leaders, Optimal care Of Life threatening POST CPR)

h. 대동맥 박리 (Aorta, Aortic dissection)

i. 거취결정 지연환자(ARRANGE, Accelerated Response and Reallocation plan for Amelioration of Non-dischargeable Gridlocked Emergency Patients)

(7) 진료과가 결정되면 환자 진료의 권한과 책임은 응급의학과에서 결정된 진료과로 옮겨지며 전출/전입을 처방한다. 전과처방과 전과기록은 입원처방과 입원기록으로 대체할 수 있다.

(8) 진단검사의학과와 영상의학과에서는 응급진료센터 환자에게 시행된 검사의 보고 시간을 모니터링하고, 지속적으로 관리한다.

① 응급검사의 신속한 결과보고가 필요한 경우, Critical value (CV) 시스템의 활성화를 통해 담당 의료진에게 문자가 발송되며, 동시에 유선으로 의료진에게 검사결과가 보고된다. 이때 결과를 보고받은 의료진은 결과를 기록하고 다시 되읽어 주며 검사결과를 보고한 사람은 내용을 재확인한다.

② 검사결과 보고시간은 세브란스병원 내규 [2.3.2.1. 검체검사 결과 보고 - 진단검사의학과], [2.3.2.2. 검체검사 결과 보고 – 병리과], [2.3.6.1.영상검사 결과 보고 – 영상의학과], [2.3.6.2. 영싱검사 결과 보고 – 핵의학과]에 따른다.

(9) 응급진료센터에서의 퇴원

① 퇴원 시에 의사는 진료과정과 경과, 향후 계획과 관련된 경과기록 또는 퇴원기록을 완료한다.

② 퇴원 시 환자용 퇴원요약과 퇴원약 및 복약지도문을 제공한다.

③ 퇴원 후 외래 등 추후방문이 필요한 경우 진료 절차를 안내한다.

(10) 응급진료센터 협력병원 병상공유 프로토콜

① 응급진료센터 체류시간 제한 기준을 초과하는 경우 입원 병실 배정이 차단되며 입원 주치의(담당교수)는 환자의 상태에 따라 우선입원 혹은 회송(전원)을 결정하여야 한다.

a. 우선입원: 본원에서의 입원치료가 반드시 필요한 환자에게 신청할 수 있다. 단, 우선입원을 신청한 환자가 병실을 배정받기 전까지 해당 주치의(담당교수)의 외래 입원 환자의 병실 배정이 후순위로 변경된다.

b. 입원장 유지 회송(전원): 타병원에서 진료가 가능하나 최종치료를 위하여 본원으로 재전입이 필요한 환자는 입원장을 발부한 후 타병원으로 회송(전원)을 할 수 있다. 이 경우 입원원무팀은 최우선 순위로 입원 병실을 배정하며 입원 병실이 배정된 경우 회송(전원) 병원에서 본원의 입원 병실로 바로 입원할 수 있도록 한다.

3) 타 의료기관과의 전출 및 전입

(1) 응급환자 회송(전원)지침 및 회송(전원) 환자 분류체계는 세브란스병원 중환자 이송체계 [부록2. STARS(Severance Inter-Hospital Transport And Resuscitation System)] 내부규정을 따른다.

(2) 병원 내 자원의 부족이나 환자의 요구로 인한 회송(전원) 여부는 의사가 결정하며, 회송(전원) 절차는 회송(전원) 코디네이터가 진행한다.

(3) 회송(전원) 사유, 회송(전원)될 기관명과 진료과, 환자 상태, 환자의 지속적인 치료 요구 등을 포함한 응급환자 회송(전원)소견서는 의사가 회송(전원)시점에 작성하며 필요한 서류와 함께 환자에게 제공한다.

(4) 회송(전원) 환자 지침

① 회송(전원) 시 필요 조건(비 응급환자의 경우)

a. 수축혈압: 정상범위의 80% 이상

b. 호흡수: 10～24회/분

c. 맥박수: 60～100회/분

d. 체온: 36～37.5℃

e. 의식 수준: 비교적 명료함

f. 입원병상이나 ICU침상 부족

② 회송(전원) 전 확인사항

a. 회송(전원)될 의료기관으로부터의 승인

b. 회송(전원)동의서 작성

c. 응급환자 회송(전원)소견서 작성

d. 의료진의 동반 여부

③ 회송(전원)과 관련된 책임

a. 회송(전원) 결정을 내린 의사는 환자 또는 대리인에게 회송(전원) 사유를 설명하고 동의서를 받는다.

b. 회송(전원) 결정을 내린 의사는 환자 정보와 소견서를 회송(전원)될 병원에 제공한다.

c. 환자상태가 불안정할 경우 의사의 지시 없이 회송(전원)되어서는 안되며, 상태에 따라 의료진 또는 응급구조사가 동행한다. 회송(전원) 중 환자의 상태를 점검하며, 필요 시 적절한 조치를 취하고 기록한다.

d. 회송(전원)받는 병원 소속 의료진이 본원에 와서 환자를 인계받는 경우, 인계 이후 환자 관리 책임은 해당 타 병원으로 이관된다.

④ 회송(전원)과 관련된 기타 사항

a. 필요한 경우 환자는 적절한 회송(전원) 수단(구급차)을 제공받는다.

(5) 회송(전원)의 적절성 및 안전성 관리

① 응급진료센터에서 이루어지는 모든 회송(전원)은 적절성과 안전성을 확보하기 위해 응급진료센터 소속 회송(전원) 담당 코디네이터들과 응급진료센터 의료진이 [부록 6. 응급 회송(전원) 조정 매뉴얼]에 따라 전입, 전출 관리를 진행한다.

4) 중증응급질환 수용 정보관리

(1) 원내 정보수집·등록과정, 등록정보 확인·수정과정, 환자 수용여부 결정 및 회신, 중증 응급환자 수용 가능 현황 등은 [부록5. 중증응급환자 수용 정보 관리 지침]에 따른다.

5) 재난 시 효과적인 의료대응을 위해 [부록7. 세브란스병원 재난대책 지침]에 따라 응급진료센터 진료체계를 변경한다.

6) 응급진료센터 내원 환자의 진료지연 최소화 및 환자안전 향상 도모를 위해 필요 시 과밀화 지표([부록3. 환자흐름 관리 프로세스] 참고)에 근거하여 과밀화가 해소되지 않는 불가피한 상황에서는 병원장 또는 진료부원장 지시 하에 응급진료 접수 중단을 시행할 수 있다.

3. 환자의 안전

1) 응급진료센터 출입을 통제한다.
   (1) 응급진료센터에 출입하려는 사람에게는 출입증을 교부하고, 출입하는 모든 사람을 정해진 서식에 따라 대장으로 관리한다.
   (2) 환자의 보호자로서 응급진료센터 출입이 가능한 사람은 원칙적으로 환자 1인당 1명으로 한다. 다만, 소아, 장애인, 주취자 또는 정신질환자의 진료 보조를 위하여 필요한 경우에는 2명으로 할 수 있다. 추가 예외 사항으로 감염의 우려가 있을 시에는 보호자를 전면 통제할 수 있다.
2) 타인에게 감염전파의 위험성이 있는 환자, 면역저하환자 또는 폭력적이고 정신적으로 불안정한 환자에게 격리실을 제공한다.
   (1) 공기매개감염환자(활동성 결핵, 수두, 홍역 등)는 격리실에 배정하고 음압을 유지한다. 공기매개감염환자가 대량으로 발생한 경우 세브란스병원 내규 [11.8.1. 유행성감염병 대량발생 시 관리]에 따른다.
   (2) 공기매개감염환자 이외의 감염병환자 중 법정 감염병환자 또는 의료진이 판단하여 격리가 필요한 환자에 대하여 격리실을 배정한다.
   (3) 면역저하환자는 의료진의 판단에 따라 역격리를 위하여 격리실을 배정하며 이 경우 양압을 유지한다.
3) 외국인 환자는 응급진료센터에서 안정을 취한 후 필요 시 국제진료센터로 의뢰한다.
4) 신원 증명이 안된 환자를 위하여 입원원무팀, 경찰서 또는 지역사회 관련 기관과 연계한다.
5) 환자가 병동으로 이동하는 경우 응급진료센터에서 이송을 담당하며, 검사, 수술, 분만 등을 위해 입원이 요구되는 경우는 환자의 이송은 이송 이후의 관련 부서(검사실, 수술실, 분만실 등)에서 담당한다.
6) 취약환자(신생아, 소아, 노인 환자, 장애환자, 의사소통이 어려운 환자, 혼수상태 환자, 그 외 위험에 노출된 환자 등)의 권리를 세브란스병원 내규 [6.2.1. 취약환자 서비스]에 따라 보호한다.

4. 병상 규정
1) 병상 이용 규정
   (1) A구역은 응급진료센터에 내원한 환자 중 Triage 결과 우선순위 1, 2 단계 및 일부 3 단계에 해당하는 환자의 응급처치를 시행하는 곳이다.
   (2) B, C구역은 응급진료센터에 내원한 환자 중 Triage 결과 우선순위 3 단계 일부와 4, 5 단계에 해당하는 성인환자의 응급처치를 시행하는 곳이다.
   (3) F구역은 간단한 검사, 투약, 처방 및 응급처치가 신속하게 시행되는 곳이다.
   (4) I구역은 감염병 의심 환자 중 공기매개감염환자를 일반 응급환자와 분리된 동선으로 격리하는 곳이며, 그 이외의 감염병 환자도 격리가 필요한 경우에는 의료진이 판단하여 배정한다.
   (5) P구역은 응급진료센터에 내원한 소아환자의 응급처치를 시행하는 곳이다.
   (6) 격리실은 공기매개감염환자, 법정 감염병환자, 면역저하환자, 신체적 위협의 위험이 있는 환자, 또는 의료진이 판단하여 격리가 필요한 환자를 진료하는 곳으로 격리실의 입실 여부는 응급의학과에서 결정한다.

2) 이용기한 규정

(1) 효율적인 진료를 위해 응급 진료 과정의 지켜야 할 시간 제한 규칙을 따른다. (본 내규 '2항 2)호 (4)목' 참조)

제4조 (부록)

1. 응급진료센터 중증도 분류
2. 세브란스병원 중환자 이송체계(STARS)
3. 환자흐름 관리 프로세스
4. 응급진료센터 출입통제
5. 중증응급환자 수용 정보 관리 지침
6. 응급 회송(전원) 조정 매뉴얼
7. 세브란스병원 재난대책 지침
8. 신종 감염병 의심환자 응급진료센터 내원 시 흐름도
9. 소아전문응급의료센터 운영관리

제5조 (참고)

1. 응급의료에 관한 법률
2. KTAS (Korean Triage and Acuity Scale)
3. 의료기관 입원환자 병문안기준 권고

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)